Signature Not Verified
Digitally signed by Medis UKC MAribor

Oddelek za psihiatrijo

MARIBOR, 29.04.2021

ODPUSTNO PISMO

DRAUČBAHER PETER
OŽBALT 53

2361 OŽBALT

Rojen-a	17.09.1984	KZZ: 040003336
Reg.št.	5518156210	
Podjetje	ELEMENTUM - AG, TRGOVINA S PLE	
Dodat.zav.		
Zap.štev.	681226 4	
Matična št.	998084	
Velj.nap.	**10.03.2021**	**Obseg poobl. 1,2,3**

Datum, ura sprejema	*Dat.,ura adm.odp.*	*Št. hospital. dni*
10.03.2021 20:10	29.04.2021 07:05	50

Datum odpusta: 29.04.2021 *Merilo ustreznosti sprejema:* 18

Sprejemni zdravnik: PETRA KOPRIVNIK, dr. med., spec. psihiatrije
Sobni zdravnik: PETRA KOPRIVNIK, dr. med., spec. psihiatrije
Predstojnik oddelka za psihiatrijo: JURE KOPRIVŠEK, dr. med., spec.psihiatrije

DIAGNOZA

23.04.2021 - F2331 Akutna psihotična motnja
23.04.2021 - F601 Shizoidna osebnostna motnja
23.04.2021 - S4200 Zlom desne ključnice (inveter.)

IZVIDI MEDODDELČNIH OBRAVNAV

FE: 421 Laboratorij nuklearne medicine
Datum, ura obravnave: **11.03.2021 09:52**
Zdravnik: prim. MITJA TOPALOVIČ, dr. med., spec. internist

FE: 822 Ambulanta za CT diagnostiko
Datum, ura obravnave: **18.03.2021 09:58**
Zdravnik: BENO POLANEC, dr. med., spec. radiolog
Napotna diagnoza: Diagnostika prve psihoze

CT glave brez KS:

Prepričljivih znakov za sveže demarkirane postishemične spremembe, krvavitev ali ekspanzivni proces ne vidim.
Ventrikularni sistem je simetričen, primerno širok, brez pomikov možganovine.
Bazalne cisterne se dobro diferencirajo.
V zadnji kotanji ne vidim posebnosti.
V področju orbit, obnosnih votlin in hipofize prepričljivih patoloških sprememb ne vidim.
Pnevmatizacija mastoidnih celic je ohranjena.

Mnenje:
Današnji izvid je v mejah normalnega.

FE: 820 Ambulanta za RTG diagnostiko
Datum, ura obravnave: **25.03.2021 09:08**
Zdravnik: MARKO EINFALT, dr. med.

Napotna diagnpoza: Star zlom ključnice?
Medis: Poškodba desne klavikule pred enim letom.

RTG desne ključnice:

Starih slik za primerjavo nimam.
Zlom srednjega dela desne ključnice z večjim premikom odlomka. Distalni del klavikule je premaknjen navzdol za 12 mm. Robovi klavikule na mestu preloma so gladki - najverjetnje stanje po starejši frakturi. 5 cm od AC sklepa je v ključnici vidna sklerotična sprememba - najverjetneje kostni kalus starejše frakture.

FE: 052 Travmatološka ambulanta 1-dopoldan
Datum, ura obravnave: **01.04.2021 09:00**
Zdravnik: prim. ALEKSANDER FRANK, dr. med.

Prihaja na konzilijarni pregled s psihiatrije. Tam se zdravi zaradi psihoze. Pred enim letom si je zlomil desno ključnico, takrat večje pozornosti temu ni namenjal. Sedaj pa opaža, da ima pri fitnesu težave v smislu bolečin v predelu desne ključnice.

ST.: v predelu desne ključnice se tiplje deformacija. Klinično odlomka ne izgleda čvrsta, se gibljeta vsak zase. Prosk. nekoliko pritiska na kožo.

RTG kontrola: gre za stanje po zlomu desne ključnice, ki je v prikrajšavi za cca. 2 cm in v dislokaciji adlatus tudi za pribl. 1,5 cm, v okolici vidnih nekaj senc kostne gostote - kalus, ki pa ne dosega obeh odlomkov in fraktura verjetno ne zarašča.

MNENJE: zaradi natančnejše diagnostike je potrebno še narediti CT d. ključnice.

Naša kontrola z izvidom.

FE: 820 Ambulanta za RTG diagnostiko
Datum, ura obravnave: **01.04.2021 09:28**
Zdr.delavec: Benjamin ŠVEC,dipl.inž.radiol.

FE: 822 Ambulanta za CT diagnostiko
Datum, ura obravnave: **06.04.2021 08:27**
Zdravnik: doc.dr. MITJA RUPREHT, dr. med., spec.radiolog

Klinični podatki: Nezaraščanje zloma desne ključnice.

CT desne ključnice:

Brez znakov preraščanja zloma ključnice v srednjem delu z večjo dislokacijo. Anteriorno pred zlomom 2,5 cm dolg trakast priostren kostni fragment, ob njem še nekaj drobcev.

Brez sprememb ostalega prikazanega skeleta.

FE: 052 Travmatološka ambulanta 1-dopoldan
Datum, ura obravnave: **08.04.2021 10:46**
Zdravnik: TOMI KUNEJ, dr. med.

Prihaja na konziliarni pregled s psihiatrije. Pri nas obravnavan zaradi non union zloma desne ključnice. Opravil je CT, ki potrdi nezaceljen zlom desne ključnice.

Mnenje: pacienta bom predstavil na konziliju Oddelka za travmatologijo. O mnenju konzilija bo pisno obveščen.

FE: 052 Travmatološka ambulanta 1-dopoldan
Datum, ura obravnave: **12.04.2021 13:00**
Zdravnik: TOMI KUNEJ, dr. med.

Pacient je bil predstavlje na travmatološkem konziliju, ki je mnenja, da je indicirana operativna terapija, osteosinteza in eventuelna spondioplastika. Pogovorim se tudi z lečečim psihiatrom dr. Zamudo, ki je mnjenja, da bo pacient perioperativno in pooperativno sposoben sodelovati.

Pri pacientu odvzamite laboratorijske preiskave, KKS, ELEKTROLITI, RETENTI, določite KG, posnamite EKG. Opravi naj konziliarni pregled pri anesteziologu. Pred premestitvijo naj ima tudi opravljen bris na Covid-19. Ko bodo vse preisakve opravljena, se za premestitev dogovorite z glavno sestro travmatološkega oddelka na 1345.

FE: 251 Enota za anesteziologijo
Datum, ura obravnave: **26.04.2021 11:00**
Zdravnik: DENIS SRAKA, dr. med.

MNENJE: Po pregledu dokumentacije ugotavljam, da gre za 36-letnega pacienta hospitaliziranega na Oddelku za psihiatrijo zaradi psihode (v remisiji), ki bo operiran zaradi eno leto starega zloma ključnice. Pri pacientu gre za shizoidno osebnostno motnjo, ki se vodi pri psihiatru, drugače je pacient brez drugih znanih pridruženih bolezni. Trenutna terapija: Risperdal 2-0-3mg, Lorsilan 0,5-0-1mg. Alergije niso znane.

Laboratorijski izvidi in koagulacija so v mejah normale. Za predoperativni klinični pregled prosim anesteziologa pristojnega za operativni poseg.

Za operativni poseg svetujem rezervacijo dveh enot koncentriranih eritrocitov. Pred operativnim posegom naj prejme Risperdal 2mg tbl in Dormicum tbl 7,5mg tbl.

LABORATORIJSKI REZULTATI

11.03.2021 07:00 TSH=2.16; FT4=16.36; FT3=5.15;

11.03.2021 08:06 S-folati=15.8; S-vitamin B12=498;

11.03.2021 08:07 K-Hemogram=.; K-levkociti=5.04; K-eritrociti=5.87; K-hemoglobin=146; K-hematokrit=0.45; MCV=76.3; MCH=24.9; MCHC=326; K-trombociti=196; Diferencialna krvna slika=.; K-nevtrofilni granulociti=2.41; K-limfociti=1.81; K-monociti=0.57; K-eozinofilni granulociti=0.21; K-bazofilni granulociti=0.04; K-nezreli granulociti=0.01; K-nevtrofilni granulociti=47.8; K-limfociti=35.9; K-monociti=11.3; K-eozinofilni granulociti=4.2; K-bazofilni granulociti=0.8; K-nezreli granulociti=0.2; S-urea (sečnina)=4.3; S-kreatinin-E=63; Ocena GF=>90; S-CRP=<3.0; S-bilirubin celokupni=10; S-bilirubin direktni=2; S-AST (GOT)=0.34; S-ALT (GPT)=0.56; S-gama GT=0.37; S-natrij (Na)=139; S-kalij (K)=4.50; S-kloridi (Cl)=107; U-specifična teža=1.019; U-pH=7.5; U-nitriti=negativno; U-proteini=0; U-glukoza=0; U-metilketoni=0; U-urobilinogen=<17; U-bilirubin=0; U-eritrociti=5; U-levkociti=4; U-bakterije=5; U-cilindri=0;

U-epitelne celice=0; U-eritrociti=0 - 3; U-levkociti=0 - 5; U-bakterije=Malo; U-cilindri=0; U-epitelne celice=0;

23.04.2021 07:58 K-Hemogram=.; K-levkociti=5.04; K-eritrociti=5.69; K-hemoglobin=139; K-hematokrit=0.43; MCV=74.9; MCH=24.4; MCHC=326; K-trombociti=189; Diferencialna krvna slika=.; K-nevtrofilni granulociti=2.42; K-limfociti=1.84; K-monociti=0.48; K-eozinofilni granulociti=0.28; K-bazofilni granulociti=0.02; K-nezreli granulociti=0.01; K-nevtrofilni granulociti=48.0; K-limfociti=36.5; K-monociti=9.5; K-eozinofilni granulociti=5.6; K-bazofilni granulociti=0.4; K-nezreli granulociti=0.2; S-urea (sečnina)=3.3; S-kreatinin-E=68; Ocena GF=>90; S-natrij (Na)=138; S-kalij (K)=4.26; S-kloridi (Cl)=108;

23.04.2021 08:06 P-Protrombinski čas=1.04; P-INR=0.97; P-Trombinski čas=18; P-aPTČ=30; P-Fibrinogen=2.20;

ZAKLJUČEK

36-letni bolnik je bil na sprejem pripeljan z reševalnim vozilom iz Psihiatrične klinike Ljubljana Polje. Priložena napotnica akutna in prehodna psihotična motnja in pripis, da je preusmerjen zaradi regijske pripadnosti. V urgentni ambulanti v Ljubljani je prejel Lorsilan 1 mg per os, preizkus alkoholiziranosti je bil negativen. Priložen tudi današnji ambulanti karton, iz katerega je razvidno, daj je prišel na CMZ v Ljubljani z bratom, ki je podal heteronamnestične podatke. Navajajo, da je bil bolnik že dvakrat v kratkem pregledan pri njih, vendar hospitalizacije ni želel, sedaj si je premislil (pac. opiše, da se je v Ljubljani obakrat prestrašil, enkrat zato, ker so pripeljali invalidski voziček, drugič pa posteljo, zato je zato je iz ambulatne pobegnil). Opisujejo hud strah, da se bo nekaj hudega zgodilo in občutke, da ga nekdo zasleduje. O tem ni želel govoriti, navajal je težave s čutenjem in prostorsko predstavo.

V Medisu je zabeležena obravnava v Urgentnem centru MB dne 21.2.2021, ko je bil pripeljan vinjen (etanol v serumu 1,3 g/l), menda naj ne bi imel encimov za presnovo alkohola, napil naj bi se iz samomorilnih namenov, UC je zapustil pred zaključkom obravnave, proti nasvetu zdravnika.

Bolnik je bil ob prihodu v našo urgentno ambulanto umirjen in sodelujoč. O predhodno opisani psihopatološki simptomatiki ni želel govoriti. Navajal je, da bi rad to prekinil, da je imel čudne občutke, o katerih ne bi govoril. Pripovedoval je splošno, o nesporazumih, o konfliktih, direktno povprašan je potrdil pretekle suicidalne namere (naj bi za to zaužil veliko alkohola), vendar trenutno naj ne bi imel nobenih samomorilnih nagnjen. Navaja, da ne želi biti nekdo, ki je večkrat pobegnil iz Polja, zato se je danes odločil, da v bolnišnici ostane, pa so ga preusmerili sem. Nenavadno naj bi se počutil približno mesec dni, v tem času se je preselil na mamin bivši dom (iz Ljubljane v Ožbalt). V zadnjem mesecu zaradi korone dela od doma, potrdil je, da je dal odpoved, vendar meni, da je še zaposlen. Po izobrazbi je pomorski tehnik, v tem poklicu ni delal, dela kot računalničar. Direktno povprašan po paranoidnih in halucinatornih doživetij ne odgovori.
Telesno naj bi bil zdrav, tudi sicer v družini naj ne bi bilo duševnih bolezni, ne uživa alkohola (razen kot omenjeno pred dnevi) in ne uživa drog. Je samski. Ima brata, ki ga je danes pospremil na kliniko v Ljubljani in mamo. Na vprašanje, kako se razumejo, ni odgovoril. Očeta ni poznal.

Psihični status ob sprejemu: luciden, pogovorljiv, a precej kontroliran, ne odgovarja na ciljna vprašanja po psihopatologiji, trenutno je kar sproščen (v Polju opisan kot napet in vznemirjen), prav tako je duktus koherenten, je pa precej psevdofilozofski in okolišav, in glede na heteroanamnestične podatke disimulira preganjalno nanašalne vsebine, suspektno pa tudi zaznavne motnje. Razpoloženje ni pomembno znižano ali privzdignjeno, prepričljivo je brez avto-in heteroagresivnih tendenc in se strinja s hospitalizacijo.

Na oddelku je bil bolnik sprva nezaupljiv, distanciran, iznašal je paranoidne blodnjave vsebine napram svojcem in spremenjeno doživljanje telesa (depersonalizacija, dif. dg. cenestetske halucinacije), afektivno je bil nerazgiban, disforičen, do psihopatologije nekritičen, ne pa avto- ali heteroagresiven. Spal je. Logika je izrazito svojska.

Uvedli smo risperidon in lorazepam.

Urin na PAS: negativen za vse testirane substance

Laboratorijski izvidi: MCV znižan (76), eritrociti povišani (5.87), preostale testirani parametri krvi in urina bp (pacient zanika poseben prehranski režim kot vzrok najdb). Normalno delovanje ščitnice.

EKG odčitan kot normalen, brez ishemičnih sprememb.

CT glave je bil odčitan kot normalen.

Opravili smo klinično-psihološki pregled (povzemam mnenje S. Plakolm / mag. B. Kremžar Jovanović): na podlagi kliničnopsihološkega pregleda ugotavljamo, da gre v osnovi za osebnostno patologijo in posledično za psihotično dekompenzacijo ob stopnjevanju tako situacijskih stresorjev kot notranjih konfliktov. Trenutno je v ospredju preokupacija z odnosi in socialnimi stiki, pri čemer je prišlo, pri sicer socialno umaknjenem in socialno manj spretnem gospodu, do čustvenega preplavljanja in posledično do izgube realitetne kontrole. Gre za gospoda, ki ima le malo socialnih stikov, v odnose vstopa nezaupljivo in previdno. V odnosih je nato hitro prizadet in ima občutek, da se mu godi krivica, zato se jim večinoma izogiba. Njegovo razumevanje socialnih interakcij ter njegove razlage misli in dejanj drugih ljudi so idiosinkratične in pogosto netočne, njegovo procesiranje čustev je izrazito kontrolirano in omejeno, doživljanju in procesiranju čustev se večinoma raje izogne. Aktualno doživlja hud stres, ki ga ne zmore obvladovati. Pričakovati je, da bo tudi v prihodnje ob stresnih situacijah, ki vključujejo socialne situacije, odreagiral z izgubo realitetne kontrole.

Drugi del zdravljenja smo opravili na rehabilitacijski enoti B1, kjer se je sprva motivirano vključeval v oddelčne aktivnosti, ob nižanju lorazepama pa je ponovno postal paranoiden in želel zapustiti bolnišnico s povsem nerealnim načrtom, zaradi česar smo ga selili na varovano enoto in o zadržanju obvestili pristojno sodišče, ki je v nadaljevanju izdalo sklep o zdravljenju brez privolitve do najdlje 29.4.2021. Zadnjih deset dni je bil ob dobrem funkcioniranju ponovno obravnavan na rehabilitacijski enoti, v začetni remisiji, subjektivno zadovoljen.

Opravili smo RTG desne ključnice in CT tega predela po stari poškodbi (nezdravljen zlom, pac. ob poškodbi ni iskal zdravniške pomoči). Travmatologi so na konziliju sklenili, da je indicirano operativno zdarvljenje (prilagamo izvide slikovne diagnostike in konziliarne izvide). Bolniku smo predlagali premestitev na travmatološki oddelek po zaključenem zdravljenju pri nas, s čimer se je strinjal. Opravili smo naročene predoperativne preiskave.

Pac. si je pod vplivom psihotičnega doživljanja povzročil precej socialne škode (odpovedal delovno razmerje, "izgubil" avtomobil v Avstriji, kršil karantenske odločbe). V obravnavo smo vključili socialno delavko in koordinatorja obravnave v skupnosti, ki je pac. na oddelku že obiskal (g. Janez Sterle). Na pacientovo željo smo vzpostavili tudi kontakt z delodajalcem.
Mama in brat sta se informirala o poteku zdravljenja.

Terapevtskih izhodov in obiskov v času zdravljenja ni bilo zaradi omejitev ob Covid-19.

Ob odpustu je sproščen, vedenjsko urejen, četudi svojski, ni produktivno psihotičen, je evtimen, vegetativne funkcije so urejene, je sodelujoč, povsem brez znakov za avto- ali heteroagresivne tendence. Premeščen je na Oddelek za travmatologijo, po zaključenem bolnišničnem zdravljenju je z naše strani nujno redno ambulantno psihiatrično zdravljenje, datume za kontrolo je že pridobil.

Pacient je premeščen na Oddelek za travmatologijo.

Splošna navodila ob odpustu
Terapija ob odpustu:
RISPERDAL 2 - 0- 3 mg, eRp.sc.III a 2 mg, sc.III a 3 mg
LORSILAN 2 x 0,5 mg (+ 0,5 mg po potrebi ob nemiru) predvidoma še za čas hospitalizacije in prvih nekaj dni po odpustu, nato naj odmerek zniža na 0,5 mg zvečer za nekaj dni in kasneje prekine jemanje tega zdravila (dokler je v terapiji Lorsilan, ni dovoljeno upravljanje motornih vozil), eRp.sc.I

Hospitalno zdravljenje na našem oddelku je zaključeno.

Bolnika premeščamo na Oddelelk za travmatologijo UKC Maribor zaradi načrtovanega operativnega posega po zlomu desne ključnice. Izvidi naročenih predoperativnih preiskav so v Medisu, EKG prilagamo. Izvid PCR na SARS-CoV-2 dne 28.4.2021 je negativen.

Bolnik naj po odpustu iz UKC Maribor v lekarni prevzame predpisana zdravila s kartico zdravstvenega zavarovanja.

Psihiatrična kontrola pri dr. Gselmanu (ZD Adolfa Drolca Maribor) 9. 6. 2021 ob 7:30h.
Pac. bo po odpustu sodeloval tudi s koordinatorjem obravnave v skupnosti pri pristojnem CSD (g. Janez Sterle), s katerim je med hospitalizacijo že navezal stik.

MNENJE: Z naše strani predlagamo še vsaj dva tedna aktivnega bolniškega staleža, nato je smiselna prehodna 4-urna delovna obremenitev (predvidoma do kontrole pri psihiatru). Glede na to, da pac. premeščamo na Oddelek za travmatologijo UKC Maribor zaradi načrtovanega operativnega posega po zlomu desne ključnice, bo bolniški stalež odvisen tudi od navodila travmatologa. Odpustno pismo pošljemo izbrani zdravnici (dr. Todorović, ZD Ljubljana Center, Metelkova).

Odpustni zdravnik (lečeči/sobni/dežurni)
PETRA KOPRIVNIK, dr. med., spec. psihiatrije

Pacient mora odpustno pismo, ambulantni karton ali drugo medicinsko dokumentacijo izročiti svojemu osebnemu zdravniku ob prvem naslednjem obisku.

V primeru morebitnih naknadnih izvidov sledi Dodatek k odpustnemu pismu.

Spoštovani, vabimo vas, da podate vaše mnenje o zadovoljstvu z opravljeno zdravstveno obravnavo v UKC Maribor tako, da izpolnite vprašalnik. Pripravilo ga je Ministrstvo za zdravje v več jezikih, je anonimen in vam je neprekinjeno dostopen tako, da v svoj spletni brskalnik vpišete: zvem vprašalnik za paciente
Hvala za vaše sodelovanje !